EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 92845
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-09-15 12:24:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA ELIANA RIVERA CONTRERAS			RUN	: 2.696.967-0
F.Nac	: 01-01-1929	Edad	: 95 AÑOS, 8 MESES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-09-14	Fecha Egreso	: 2024-09-15 12:24:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Acv antiguo
HTA
Azheimer
Dependiente severa

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente traída por SAMU por cuadro de 3 a 4 días de deterioro progresivo de su estado general. Hoy somnolienta, poco reactiva, por lo que deciden acudir a urgencias.
En examenes de laboratorio destaca cambios en la orina compatibles con proceso inflamatorio.
TAC de cerebro sin hallazgos de carácter agudo. Infarto parietal izquierdo antiguo.
Paciente sin requerimiento de oxígeno, hemodinamia estable se hidrató por más de 12 horas, desde anoche más despierta, en su basal según cuidadora.
Familiar solicita HODOM y en vista de mejoría de estado de conciencia se decide continuar manejo en HODOM.

PLAN DE MANEJO:

Rescatar urocultivo día martes.
Control de ex mañana.
Según urocultivo podría pasar a atb oral.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Regimen papilla bien sentada y bien despierta
3. Ceftriaxona 2 gr ev
4. Losartan 50mg 1 c 12hrs vo
5. Aspirina 100mg vo
6. Medicación crónica de forma habitual, en caso de persistir con somnolencia debe consultar con médico tratante extrasistema para que ajuste el tratamiento para el Alzheimer.

PANIQUE PEDRAZA MARIANA ANDREA
MEDICO TRATANTE
24689611-9

JEFE SERVICIO